

NEUROSOFT APP

Bienvenido

al programa de beta testing.

*Esta guía explica qué es NeuroSoft App,
qué puedes hacer con ella, cómo instalarla y
cómo reportar feedback durante el periodo de prueba.*

DESARROLLADO POR

Johan Sebastián Salgado Sarmiento

Psicólogo · Universidad Nacional de Colombia

jssalgadosa@unal.edu.co

01 · INTRODUCCIÓN

Qué es *NeuroSoft App*.

NeuroSoft App es un sistema integral para la práctica clínica de psicólogos y neuropsicólogos en Colombia. Combina evaluación neuropsicológica computarizada, rehabilitación cognitiva, sesiones de psicoterapia con notas SOAP, telemedicina y un asistente de IA local — todo en una sola aplicación de escritorio que se instala como un programa cualquiera.

Tiene cargados **168 baremos colombianos** y latinoamericanos (Neuronorma Colombia, Arango-Lasprilla & Rivera 2015, ENI-2, WISC-IV, WAIS-III, MoCA-S Bogotá). El motor de scoring calcula automáticamente escalares, índices, percentiles y discrepancias clínicas.

168PRUEBAS CON
BAREMOS**3**

PILARES CLÍNICOS

45+

RECURSOS EDUCATIVOS

100%

OFFLINE-CAPABLE

Estado actual

Versión **2.0.0** — Beta cerrada con profesionales seleccionados. Los baremos están verificados con casos clínicos reales (no es un simulador). Todo el procesamiento ocurre en tu computadora; ningún dato del paciente se envía a servidores externos.

02 · ARQUITECTURA

Los tres *pilares clínicos*.

NeuroSoft se organiza en tres pilares complementarios. Cada uno puede usarse de forma independiente, pero se diseñaron para flujos integrados (evaluar → tratar → educar al paciente).

PILAR 1 · EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

Aplicar, calificar y redactar *en una sola sesión*.

- **Aplicación guiada:** cronómetro de subtests, conductas observables por test, ítem por ítem cuando aplica, autosave cada 30 segundos.
- **168 pruebas con baremos colombianos** distribuidas por población (92 infantil, 30 adulto joven, 64 adulto mayor) — disponibles en el menú «Aprender · Pruebas disponibles».
- **10 estrategias de cálculo:** escalar, índice compuesto, percentil, puntaje Z, ajuste por escolaridad, etc. Cubre WISC-IV, WAIS-III, ENI-2, Neuronorma, Stroop, TMT, FCRO, MoCA, MMSE, GADS, GROBER, entre otras.
- **Discrepancias entre índices** con tablas Flanagan & Kaufman, e indicadores de validez de síntomas (Rey 15-item).
- **Informes PDF profesionales:** 7 variantes (Pro adulto, Pediátrico, Medicolegal, Junta Médica, Inconcluso, Cierre terapéutico, Estándar).
- **Re-test con RCI:** comparativo Pre-Post con Reliable Change Index (Jacobson & Truax 1991) para detectar cambios clínicamente significativos.

PILAR 2 · PSICOTERAPIA + REHABILITACIÓN

Sesiones SOAP, tareas-casa *y entrenamiento cognitivo*.

- **Notas SOAP estructuradas** (Subjetivo, Objetivo, Análisis, Plan) con modalidad (presencial, telepsicología, telefónica), modalidad de riesgo suicida (C-SSRS), alianza terapéutica y estado emocional pre-post.
- **23 enfoques terapéuticos catalogados:** TCC, DBT, ACT, EMDR, Schema Therapy, Sistémica, Logoterapia, Mindfulness, entre otros.
- **Tareas terapéuticas entre sesiones** (Kazantzis et al. 2016, $g \approx 0.48$): registros de pensamientos, autorregistros conductuales, exposición, activación conductual, habilidades DBT, psicoeducación.
- **16 actividades de rehabilitación cognitiva:** Stroop, N-Back, Corsi (forward y backward), CPT, Go/No-Go, Fluidez verbal, Set Shifting, Tachado, Rotación Mental, Reconocimiento Ekman, Spaced Retrieval, Torre de Londres, Mente en los Ojos, AVD-Dinero, y más.
- **Telerehab:** el paciente recibe un link público (sin login) para completar actividades desde casa. El clínico ve adherencia en tiempo real.
- **Firma irreversible de sesiones** conforme a Resolución 1995 de 1999.

PILAR 3 · APRENDER (BIBLIOTECA + PRUEBAS)

Bibliografía curada *y catálogo de pruebas disponibles.*

- **Biblioteca clínica** con 45+ recursos curados en 9 categorías: Neuropsicología, Psicoterapia, Infantil, Adulto Mayor, Instrumentos, Ética y Legal Colombia, Investigación, Rehabilitación.
- **Pruebas disponibles:** catálogo navegable de las 168 pruebas con baremos, filtrable por población, fuente normativa y tipo de cálculo.
- Cada ficha indica autor, año, fuente, formato (PDF abierto / suscripción / libro físico) y nivel (básico / intermedio / avanzado).

03 · INSTALACIÓN

Cómo poner *NeuroSoft a funcionar.*

Recibes un único archivo: *NeuroSoft-Setup.exe* (~1.4 GB). Es un instalador estándar de Windows — funciona igual que cualquier otro programa que hayas instalado.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

Sistema operativo	Windows 10 o Windows 11 (64-bit)
Procesador	Intel i5 / AMD Ryzen 5 o superior
Memoria RAM	8 GB (16 GB recomendado si usarás IA local)
Espacio en disco	5 GB (incluye Ollama opcional)
Conexión a internet	Solo para instalar y opcional al usar IA externa

PASOS PARA INSTALAR

Tres clicks *y estás listo.*

- 1. **Doble-click** en *NeuroSoft-Setup.exe*. Si Windows muestra «SmartScreen impidió el inicio...», pulsa «Más información» → «Ejecutar de todas formas» (el archivo no está firmado digitalmente porque es beta).
- 2. **Sigue el asistente**: aceptar términos → elegir carpeta de instalación (default: C:\Program Files\NeuroSoft) → elegir si crear acceso directo en el escritorio.
- 3. **Al finalizar**, marca «Abrir el Manual del Beta Tester» (opcional) y lanza NeuroSoft desde el menú Inicio o el ícono del escritorio.

Primer arranque (puede tardar ~30 segundos)

La primera vez que abres NeuroSoft, el programa crea la base de datos local en %APPDATA%\NeuroSoft\ y carga los 168 baremos en memoria. Verás una pantalla de carga «Preparando tu consultorio...» — es normal. Si pasados 12 segundos sigue en blanco, aparecerá un botón «Reintentar (limpiar caché)».

CREDENCIALES DE ACCESO

Tu usuario *de beta tester.*

Usuario	beta
Contraseña	BetaTester2026!
Rol	Profesional (sin permisos administrativos)

Puedes cambiar tu contraseña desde *Configuración* → *Mi cuenta* en cualquier momento. Si olvidas la contraseña, contacta al desarrollador.

04 · CÓMO TESTEAR

Plan de prueba *sugerido*.

No hace falta probar todo de una. Te sugiero recorrer NeuroSoft en 4 sesiones cortas de 30-45 minutos cada una, simulando un caso clínico real. Anota lo que te parezca raro, lento, confuso, incorrecto o simplemente bonito.

SESIÓN 1 · ALTA Y EVALUACIÓN (45 MIN)

- Crear paciente nuevo desde *Pacientes* → *Registrar*.
- Llenar la Historia Clínica (atajos: Alt+H abre el panel de atajos).
- Aplicar una evaluación corta (recomendado: WISC-IV con un niño imaginario de 10 años) — al menos 5-6 subtests.
- Pulsar Finalizar y revisar el informe en *Resultados*.
- Generar un PDF en variante «**Pro**» y otro en variante «**Pediátrico**»; comparar.

SESIÓN 2 · PSICOTERAPIA (30 MIN)

- Ir a *Psicoterapia* → *Sesiones clínicas*, seleccionar el paciente.
- Crear un Plan terapéutico (enfoque sugerido: TCC) con 2 objetivos SMART.
- Registrar una sesión SOAP: completar las 4 secciones, marcar riesgo, asignar 1-2 tareas terapéuticas entre sesiones.
- Firmar la sesión y verificar que queda bloqueada para edición.

SESIÓN 3 · REHABILITACIÓN (30 MIN)

- Ir a *Rehabilitación* → *Plan & Actividades*.
- Crear plan de rehab con 2-3 actividades (sugeridas: Stroop, Corsi).
- Ejecutar una actividad y verificar que el cronómetro y la captura de respuestas funcionan.
- Probar el modo **Telerehab**: generar link público y abrirlo en otra pestaña/dispositivo para simular al paciente desde casa.

SESIÓN 4 · APRENDER + CONFIG (20 MIN)

- Explorar *Aprender* → *Biblioteca clínica* y filtrar por categoría.
- Ver *Aprender* → *Pruebas disponibles* y revisar 2-3 fichas.
- Probar modo oscuro (Alt+D) y revisar contraste en varias pantallas.
- Generar un backup desde *Configuración* → *Respaldo*.
- Revisar la **Configuración**: los tabs ahora están agrupados en 3 secciones (Mi consultorio / Datos clínicos / Sistema) — ¿es más fácil encontrar lo que buscas?

Novedades UI en esta build (mayo 2026)

Dashboard rediseñado: ahora incluye un banner de bienvenida con descripción de cada módulo, para que quede claro qué hace el sistema desde el primer uso.

Panel de conductas observadas más ancho en Aplicar Evaluación: el sidebar derecho pasó de 320 px a 416 px, y ahora es fijo (sticky) mientras navegas las instrucciones — más espacio para las notas clínicas.

Screening reorganizado: las escalas se agrupan en tarjetas por categoría (Cognitivo / Emocional / TDAH / Conductual / Funcional / Trauma) con iconos, en vez de una fila interminable de botones.

Configuración en 3 grupos: los 13 tabs se presentan en una tabla claramente separada por sección con descripción de qué contiene cada una.

05 · CÓMO REPORTAR

Tu feedback es *lo más valioso*.

*Cualquier formato sirve: email, WhatsApp, mensaje de voz, screenshot, lo que sea más rápido para ti. Lo importante es que **NO te autocensures** — si algo te parece mal, díme, aunque sea cosmético.*

PARA UN BUG O PROBLEMA

- **Qué pantalla** estabas viendo (ej. «Aplicar evaluación, subtest Vocabulario WISC-IV»).
- **Qué hiciste** antes de que pasara (la secuencia de clicks).
- **Qué esperabas** que pasara.
- **Qué pasó** realmente (cita textual del mensaje si hubo).
- **Screenshot** si es visual.

PARA UNA SUGERENCIA / MEJORA UX

- **Qué hacías** y qué te incomodó o te pareció lento.
- **Cómo lo harías tú** (aunque sea una idea informal).
- **Cuánto te molestó**: bloqueante / molesto / cosmético.

PARA UNA DUDA CLÍNICA

- **Qué prueba o cálculo** te genera dudas.
- **Caso concreto**: edad, sexo, escolaridad, PD ingresado.
- **Qué resultado obtuviste** y por qué te parece raro.
- **Con qué fuente** normativa esperarías comparar (manual, libro, paper).

Canal de comunicación

Email: jssalgadosa@unal.edu.co · WhatsApp / mensaje directo · Respuesta esperada en **24-48 horas**.
Acumulo feedback de todos los beta testers y libero builds nuevas cada 1-2 semanas con los fixes priorizados.

Lo que NO necesito que reportes

Cambios de copia menores («mejor decir 'paciente' que 'usuario'») los estoy puliendo paso a paso. Tampoco fuentes ni colores — ya cerramos la identidad visual. Enfócate en **clínica, scoring, flujos de trabajo** y cualquier cosa que rompa o confunda.

06 · ASISTENTE IA

Cómo funciona *el asistente clínico*.

NeuroSoft incluye un **Asistente IA** que ayuda a mejorar la redacción de informes, sugerir hipótesis diagnósticas, y explicar discrepancias entre índices. La IA es **opcional** — todo el resto del programa funciona sin ella.

MODOS DISPONIBLES

Modo 1 · Ollama local

Modelo de IA corriendo en tu computadora. **100% privado** (ningún dato sale de tu equipo). Requiere instalar Ollama (~700 MB) y descargar un modelo (~4-6 GB). Recomendado: Llama 3.1 8B. El setup automático lo deja listo si tienes RAM $\geq$ 8GB.

Modo 2 · API externa

Conecta con Anthropic Claude o OpenAI GPT-4 vía API key tuya. Más capaz que Ollama local, pero **envía el texto a servidores externos**. Solo usar con texto anonimizado (no nombres ni documentos de identidad). Configurar en *Asistente IA* → *Proveedor*.

Modo 3 · Apagado

Sin IA. Todas las funciones clínicas (evaluación, scoring, informes, rehab, sesiones) siguen funcionando exactamente igual.

QUÉ ESPERAR DE LA IA EN ESTA BETA

Útil para borradores — *nunca para reemplazar tu juicio clínico*.

- **Mejorar redacción de observaciones:** pulir gramática, evitar regionalismos, mantener tono clínico formal.
- **Sugerir hipótesis diagnósticas** dado un patrón de puntajes — la IA muestra DSM-5 / CIE-10 candidatos, tú decides cuáles aplican.
- **Explicar discrepancias entre índices** en lenguaje accesible para la familia o el remitente.
- **Generar plan de rehabilitación inicial** a partir de los dominios bajos detectados.

Limitaciones y responsabilidad clínica

La IA puede equivocarse — especialmente con baremos no estándar o casos atípicos. **El informe final es responsabilidad del clínico**, no de la IA. NeuroSoft incluye disclaimers automáticos en cada salida IA que recuerdan revisar manualmente antes de firmar.

Si la IA dice una barbaridad, **repórtalo** — me ayuda a afinar los prompts del sistema.

07 · PRIVACIDAD Y LEGAL

Tus datos clínicos *están en tu computadora.*

NeuroSoft cumple con el marco legal colombiano para datos clínicos:

- **Ley 1581 de 2012 · Habeas Data:** datos sensibles solo en tu equipo, ninguna sincronización en la nube por defecto.
- **Ley 1090 de 2006 · Código Deontológico:** secreto profesional, consentimiento informado guiado en el alta del paciente.
- **Resolución 1995 de 1999 · Historia Clínica:** trazabilidad de cambios (audit log), firma irreversible de sesiones, conservación.
- **Ley 1616 de 2013 · Salud Mental:** enfoque integral, derecho a la atención digna.

DÓNDE QUEDAN TUS DATOS

Toda la información del paciente vive en una base de datos SQLite local en:

```
C:\Users\<TuUsuario>\AppData\Roaming\NeuroSoft\neurosoft.db
```

Puedes generar backups manuales (.db) desde *Configuración* → *Respaldo*. Recomiendo hacer uno por semana durante el periodo de prueba — los pegas en tu OneDrive / Drive personal y listo.

Si decides dejar de usar NeuroSoft

Puedes desinstalar el programa desde *Configuración de Windows* → *Apps*. La carpeta %APPDATA%\NeuroSoft **NO se borra automáticamente** — contiene tus datos clínicos. Bórrala manualmente solo si estás segura de no querer recuperar las evaluaciones realizadas.

08 · CIERRE

Gracias por *acompañar este proyecto.*

NeuroSoft App nace de una frustración personal — los softwares clínicos existentes en Colombia son caros, fragmentados o no tienen baremos locales. Construirlo solo ha sido difícil; tenerte como beta tester lo hace más fácil.

Cada error que reportas, cada sugerencia, cada «esto está confuso» termina convirtiéndose en una mejora concreta. Las primeras cinco betas previas ya cambiaron decenas de cosas: el flujo de evaluación, los textos clínicos, los baremos, la estética del informe.

Toma tu tiempo, no hay deadline duro. Si tienes una semana ocupada, pausa. Si encuentras algo raro, escríbelo — incluso si dudas si vale la pena reportarlo. Casi siempre vale.

— *Johan Sebastián Salgado Sarmiento*

Psicólogo · Universidad Nacional de Colombia

Mayo 2026